



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 04 — Agitação Psicomotora, Surto Psicótico e Crise Psiquiátrica no PS

Reconhecimento do quadro (orgânico × psiquiátrico × intoxicação), abordagem não violenta e de-escalação verbal, contenção química por perfil, contenção mecânica como último recurso, risco de suicídio, aspectos legais (Lei 10.216) e articulação com o CAPS — cenário: pronto-socorro sem leito psiquiátrico

Código	PS-ND-04	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

A crise psiquiátrica no PS é, antes de tudo, uma **emergência médica**: até 1/3 das agitações agudas têm causa orgânica ou tóxica (hipoglicemia, hipóxia, infecção, TCE, abstinência, intoxicação) e o erro mais grave é sedar sem examinar. É também um encontro em que a assimetria de poder é máxima: a conduta deste protocolo parte do princípio de que **a pessoa em crise é sujeito, não objeto** — a de-escalação verbal é o tratamento de primeira linha, a medicação é oferecida antes de ser imposta, a contenção mecânica é o último recurso, por tempo mínimo e com vigilância, e tudo é registrado. O objetivo não é "apagar" o paciente, mas **reduzir a agitação a um nível que permita avaliação e cuidado** (RASS 0 a -1), preservando a dignidade e a segurança de todos.

Fontes de ancoragem: Baldaçara L, Ismael F, Leite V, et al. **Brazilian guidelines for the management of psychomotor agitation. Part 1: non-pharmacological approach. Braz J Psychiatry 2019;41:153-167; Part 2: pharmacological approach. Braz J Psychiatry 2019;41:324-335** (Associação Brasileira de Psiquiatria) [ABP 2019]; Richmond JS, et al. Verbal de-escalation of the agitated patient: consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA. *West J Emerg Med* 2012;13:17 [BETA 2012]; Wilson MP, et al. Project BETA — psychopharmacology of agitation. *West J Emerg Med* 2012;13:26; NICE NG10. Violence and aggression: short-term management (2015) [NICE 2015]; Huf G, Coutinho ES, Adams CE (TREC-Rio). *BMJ* 2007;335:869 (midazolam × haloperidol + prometazina) [TREC]; Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.048/2002 (urgências psiquiátricas), Portaria nº 3.088/2011 (RAPS) e *Guia de Vigilância em Saúde* (notificação de violência autoprovocada); **Lei nº 10.216/2001** (direitos da pessoa com transtorno mental; internação involuntária); Resolução CFM nº 2.057/2013 (consolida normas éticas em psiquiatria) e Parecer CFM sobre contenção; Resolução COFEN nº 427/2012 (contenção mecânica pela enfermagem); Lei nº 13.819/2019 (Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio); Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS) e Escala de Agitação-Sedação de Richmond (RASS).

Convenção de confiança: doses seguem a ABP 2019/BETA e o TREC; fármacos indisponíveis no Brasil (droperidol, loxapina inalatória) foram omitidos; olanzapina e ziprasidona IM constam com flag de disponibilidade. **[VERIFICAR]:** fluxo com CAPS/SAMU/Polícia Militar, sala segura, faixas de contenção adequadas, formulário de contenção, comunicação ao Ministério Público.

1. Queixa — como o paciente chega

Trazido pela família, SAMU ou polícia: "está agressivo, quebrou a casa", "fala coisas sem sentido, diz que estão perseguindo", "não dorme há dias, gasta tudo, fala sem parar" (mania), "ameaçou se matar / se cortou / tomou remédios", "usou pedra/álcool e ficou descontrolado", "parou o remédio psiquiátrico", "idoso que ficou confuso e agitado de repente" (delirium). O próprio paciente pode chegar pedindo ajuda: "estou com muita angústia, não consigo parar de pensar em morrer", "tenho medo de fazer alguma coisa".

Primeiros 60 segundos — segurança e triagem

- Avaliar o ambiente: saída livre, objetos perigosos removidos, distância de segurança (2 braços), nunca sozinho com paciente violento, equipe avisada (código interno).
- Perguntar ao acompanhante em separado: história psiquiátrica e medicações, uso de álcool/drogas (última dose), trauma, febre, diabetes, epilepsia, doença prévia, tempo de evolução, gatilho, armas.
- Triagem física imediata mesmo sem cooperação: **glicemia capilar, SpO₂, temperatura, pupilas, sinais de TCE**, odor etílico, sudorese, tremor.
- Classificar a agitação (RASS) e o risco de violência iminente (seção 2.2) para decidir se há tempo para de-escalação verbal.

2. Clínica — reconhecimento do quadro, gravidade e risco

2.1 Delirium/orgânico × psiquiátrico primário × intoxicação/abstinência — a primeira decisão

Sugere causa ORGÂNICA (delirium) — investigar antes de rotular	Sugere transtorno PSIQUIÁTRICO primário	Sugere INTOXICAÇÃO / ABSTINÊNCIA
• Início agudo (horas/dias) em quem nunca teve psiquiatria, sobretudo >40 anos ou <12 anos • Flutuação do nível de consciência, desatenção, desorientação • Alucinações visuais, táteis; ilusões • Sinais vitais anormais: febre, hipóxia, hipotensão, taquicardia • Sinal neurológico focal, convulsão, cefaleia, rigidez de nuca, trauma • Doença médica/medicação nova (anticolinérgico, corticoide, opioide, BZD), pós-operatório, idoso, demência • Glicemia alterada, hiponatremia, uremia, hepatopatia	• História psiquiátrica prévia, evolução subaguda (semanas), suspensão de medicação • Consciência preservada, orientado, atento (embora desorganizado) • Alucinações auditivas, delírios estruturados (persecutório, grandeza) • Humor: euforia/irritabilidade com insônia, logorreia, hipersexualidade (mania) ou tristeza/anedonia/ideação suicida (depressão) • Sinais vitais normais (exceto taquicardia da ansiedade) • Idade 15–40 anos no primeiro episódio psicótico	• Odor etílico, tremor, sudorese, taquicardia, hipertensão, midríase (cocaína/anfetamina/abstinência) ou miose (opioide) • Alucinações visuais/táteis ("bichos"), tremor grosseiro, convulsão 6–48 h após parar de beber (abstinência alcoólica → delirium tremens) • Agitação extrema com hipertermia, rigidez, taquicardia, força desproporcional ("delirium excitado" por cocaína/crack — risco de morte súbita) • Uso de canabinoides sintéticos, cetamina, LSD; anticolinérgicos (pele seca, retenção, midríase) • Abstinência de BZD/barbitúrico (convulsão, hipertensão)

Regra: **agitação nova + qualquer sinal vital anormal, desatenção ou idade >40 anos sem história psiquiátrica = orgânico até prova em contrário** → investigar (seção 4) e tratar a causa; sedar apenas o necessário para a segurança. "Surto" não é diagnóstico: registrar a síndrome (psicótica, maníaca, depressiva, ansiosa, dissociativa, orgânica, tóxica).

2.2 Gravidade da agitação (RASS) e risco de violência

RASS	Descrição	Conduta
+4 Combativo	Violento, perigo imediato para a equipe	Segurança; contenção física breve para medicar; medicação IM; equipe de 5 pessoas
+3 Muito agitado	Puxa/retira dispositivos, agressivo verbalmente	De-escalação + medicação (oferecer VO; IM se recusa e risco)
+2 Agitado	Movimentos frequentes não intencionais, inquieto	De-escalação verbal; medicação VO oferecida
+1 Inquieto	Ansioso, apreensivo, sem agressividade	Ambiente, escuta, ansiolítico VO se desejar
0 / -1	Alerta e calmo / sonolento responsivo	Alvo da intervenção
-3 a -5	Sedação moderada a profunda	Evitar: monitorar via aérea/SpO ₂ ; risco de aspiração

Preditores de violência iminente: postura tensa, punhos cerrados, fala alta/ameaças, invasão do espaço, olhar fixo, andar de um lado a outro, batidas em objetos, história de violência recente, intoxicação, psicose com delírio persecutório dirigido, homem jovem, arma. A escala BARS ou a observação "está piorando apesar da conversa?" bastam para decidir.

2.3 Risco de suicídio — avaliar em toda crise psiquiátrica [C-SSRS; Lei 13.819/2019]

Perguntar (em sequência, com naturalidade)	Fatores que elevam o risco	Conduta por nível
1. "Nas últimas semanas, desejou estar morto ou dormir e não acordar?" 2. "Teve pensamentos de se matar?" 3. "Pensou em como faria?" (método) 4. "Teve intenção de agir?" 5. "Chegou a planejar detalhes (quando, onde, meios)?" 6. "Já fez algo, começou a fazer ou se preparou (comprou, escreveu carta, deu bens)?" Tentativa atual: método, letalidade, intenção, expectativa de ser encontrado, arrependimento	Tentativa prévia (o mais forte); plano/meio disponível (arma, medicação); intoxicação; desesperança; psicose com vozes de comando; alta recente de internação; perda recente; dor crônica/doença grave; isolamento; homem >60 anos ou jovem LGBTQIA+ em conflito; história familiar; impulsividade; automutilação recorrente	Baixo (ideação passiva, sem plano/intenção, com suporte): plano de segurança escrito, retirada de meios, CAPS em ≤7 dias, familiar orientado. Moderado (ideação ativa sem plano imediato): observação no PS até avaliação psiquiátrica/CAPS no mesmo dia, acompanhante contínuo. Alto (plano/intenção/tentativa recente de alta letalidade, psicose, sem suporte): não dar alta ; vigilância 1:1; transferência/internação (voluntária ou involuntária).

Toda tentativa de suicídio e automutilação é de **notificação compulsória imediata (24 h)** — ficha de violência interpessoal/autoprovocada (SINAN) — e de comunicação ao CAPS de referência. Perguntar sobre suicídio **não** induz o ato; não perguntar deixa o risco invisível.

3. Exame físico — o que procurar (feito assim que a segurança permitir)

Item	Achado / significado
Sinais vitais completos + glicemia + SpO ₂ + temperatura	Qualquer anormalidade desloca para orgânico/tóxico; hipertermia + agitação = emergência (delirium excitado, síndrome serotoninérgica, neuroléptica maligna, abstinência)
Nível de consciência e atenção (dizer os meses de trás para frente; contar de 20 a 1)	Desatenção = delirium
Pupilas, nistagmo, hálito, sudorese, pele (seca × úmida), tremor, mioclonias	Toxíndromes (2.1); síndrome serotoninérgica (clônus, hiperreflexia, diarreia) em uso de ISRS/tramadol/lítio
Sinais de trauma (couro cabeludo, face, otorragia), rigidez de nuca, déficit focal, marcha	TCE, meningite, AVC → TC/transferência
Rigidez em cano de chumbo, hipertermia, instabilidade autonômica, CPK alta em usuário de antipsicótico	Síndrome neuroléptica maligna — parar antipsicótico, resfriar, volume, transferir
Lesões autoinfligidas (cortes em antebraço/coxa, cicatrizes), marcas de enforcamento, hematêmese/vômito medicamentoso	Tentativa de suicídio — avaliar intoxicação (Protocolo 23), sutura, tétano
Sinais de violência sofrida (hematomas em fases diferentes, lesões em locais protegidos), medo do acompanhante	Violência doméstica/sexual — atendimento em separado, notificação, Lei Maria da Penha, encaminhamento (ver framework de documentos formais)
Estado nutricional, hidratação, higiene, sinais de doença crônica	Autonegligência, mania/depressão graves, demência

4. Propedêutica armada — o mínimo que exclui o orgânico

Em paciente com **história psiquiátrica conhecida, exame físico e sinais vitais normais, orientado e sem uso de substâncias**, exames de rotina não são necessários (BETA/ABP). Em **primeiro episódio, idoso, sinais vitais anormais, desatenção, suspeita de intoxicação ou antes de internação involuntária**, colher o conjunto abaixo.

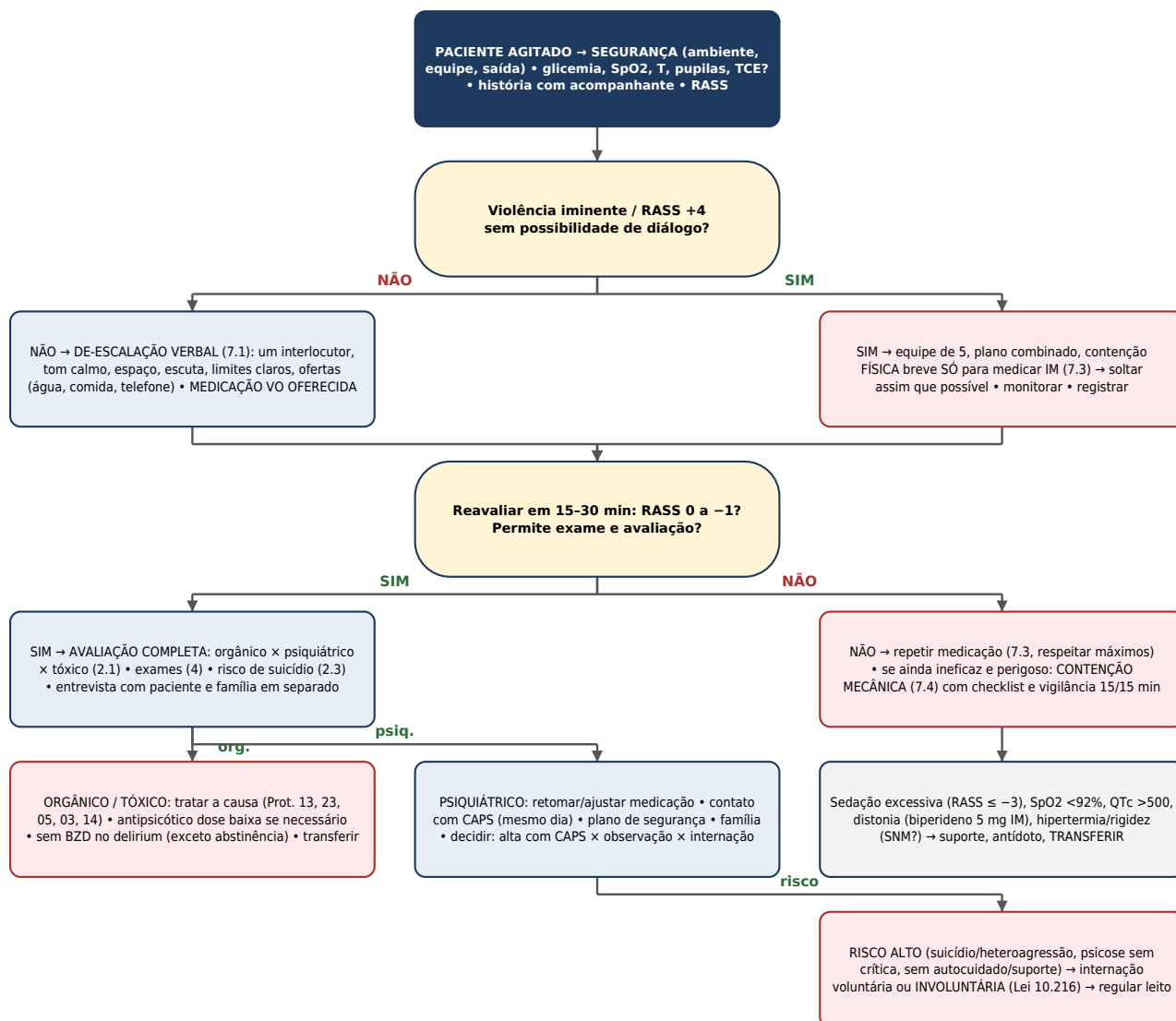
Exame	Para que serve	Quando
Glicemia capilar	Hipoglicemia (mimetiza tudo)	Sempre, na triagem
Hemograma, eletrólitos (Na, Ca), creatinina/ureia, TGO/TGP, glicemia, TSH	Delirium metabólico, hiponatremia (psicose, polidipsia, carbamazepina), uremia, hepatopatia, tireotoxicose/hipotireoidismo	Primeiro episódio, idoso, orgânico suspeito
Urina I, β-hCG	ITU (delirium no idoso); gestação (muda medicação e conduta)	Idoso; toda mulher em idade fértil
Triagem toxicológica urinária (cocaína, anfetaminas, THC, BZD), etanol	Intoxicação; não muda o manejo agudo mas orienta seguimento	Se disponível [VERIFICAR]
ECG	QTc antes de antipsicótico (haloperidol/ondansetrona), arritmia, intoxicação por tricíclico, lítio	Sempre que possível antes da medicação; obrigatório se cardiopata/idoso/polifarmácia
CPK, lactato, gasometria	Delirium excitado, SNM, rabdomiólise por contenção/agitação prolongada	Agitação grave/hipertermia/contenção
TC de crânio	Trauma, déficit focal, primeiro episódio >40 anos, anticoagulado, sem melhora	Selecionado — transferir se sem TC
Níveis séricos (lítio, valproato, carbamazepina, paracetamol)	Intoxicação/toxicidade em usuário; paracetamol em toda ingestão intencional	Conforme história
Punção lombar	Febre + confusão/rigidez de nuca; encefalite (anti-NMDA em jovem com psicose + convulsão + discinesia)	Referência

5. Fisiopatologia (o que a medicação faz e por que a abordagem importa)

A agitação é um estado final comum de hiperativação de circuitos límbicos e de alerta, com predomínio dopaminérgico (psicose, mania, cocaína/anfetamina), noradrenérgico (ansiedade, abstinência, dor) e/ou déficit GABAérgico (abstinência de álcool/BZD), sobre um córtex pré-frontal que perdeu a capacidade de inibição. A **de-escalação verbal** atua nesse sistema: reduzir estímulos, oferecer previsibilidade e controle ("você prefere o comprimido ou a injeção?") e validar a emoção diminuem a ativação de ameaça — por isso funciona e é primeira linha. Os **benzodiazepínicos** potencializam o GABA (sedação, ansiólise, anticonvulsivante) e são a escolha na intoxicação por estimulantes e nas abstinências, mas deprimem a respiração, sobretudo com álcool. Os **antipsicóticos** bloqueiam receptores D2 (tranquilização sem sedação profunda, antipsicótico) ao custo de distonia aguda, acatisia, prolongamento do QT e, raramente, síndrome neuroléptica maligna; a **prometazina** associada ao haloperidol acrescenta sedação anti-histamínica e previne a distonia (TREC). No **delirium**, a causa é uma falência metabólica/inflamatória do cérebro: sedativos, sobretudo BZD, pioram a confusão e a mortalidade — a intervenção é tratar a causa e usar antipsicótico em dose baixa só para segurança. A **contenção mecânica** prolongada provoca rabdomiólise, trombose, aspiração, asfixia posicional e trauma psíquico — daí o limite de tempo e a vigilância obrigatória.

6. Fluxo de atendimento [ABP 2019; BETA 2012, adaptado]

Sequência: **segurança** → **de-escalação** → **medicação (oferecida, depois administrada)** → **avaliação** → **causa** → **destino**. A contenção física existe para viabilizar a medicação, não como tratamento; a mecânica prolongada é o último recurso e tem regras.



■ Entrada

■ Decisão

■ Conduta

■ Risco / atenção

■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo e monitorização

Item	Meta
Triagem física (glicemia, SpO ₂ , T) em paciente agitado	≤10 min da chegada, mesmo antes da cooperação plena
Tentativa estruturada de de-escalação antes de medicar (se não há violência iminente)	10–15 min, por um único interlocutor treinado
Reavaliação após medicação IM	15–30 min (RASS, sinais vitais, SpO ₂); sinais vitais a cada 30 min por 2 h após BZD IM
Contenção mecânica	Checagem a cada 15 min (perfusão, pele, respiração, hidratação, eliminações); reavaliação médica e tentativa de retirada a cada 1 h; máximo pretendido: 2–4 h ; nunca em decúbito ventral
Contato com CAPS / regulação de leito	No mesmo turno; documentar horário e interlocutor
Comunicação ao Ministério Público (internação involuntária)	Em até 72 h da internação (Lei 10.216, art. 8º § 1º) — responsabilidade do estabelecimento que interna; o PS documenta e informa a referência

6.2 Destino: alta com CAPS × observação × internação

Alta com seguimento (todos)	Internação (voluntária ou involuntária) — qualquer um
• RASS 0, sem risco iminente de auto/heteroagressão, com crítica mínima ou familiar responsável presente • Causa orgânica excluída ou tratada • Risco de suicídio baixo/moderado com plano de segurança e retirada de meios • Medicação ajustada, receita, orientações escritas ao familiar • Contato feito com o CAPS (Estiva Gerbi/referência regional) com data de acolhimento em ≤72 h (mesmo dia se moderado) • Sem intoxicação ativa (aguardar sobriedade para reavaliar risco)	• Risco alto de suicídio (plano, intenção, tentativa grave, psicose com vozes de comando, sem suporte) • Heteroagressividade persistente ou ameaça dirigida com meios • Psicose/mania sem crítica com incapacidade de autocuidado ou risco grave (exposição, gastos, sexualidade de risco) • Delírium/orgânico não resolvido, intoxicação grave, abstinência alcoólica complicada • Falha do tratamento ambulatorial com deterioração; gestante/puérpera com psicose; catatonia; recusa alimentar grave • Ausência total de rede de suporte para caso moderado

Lei 10.216/2001: internação só quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes (art. 4º); voluntária (consentimento escrito), involuntária (a pedido de terceiro, com laudo médico circunstanciado, comunicada ao Ministério Público em 72 h) ou compulsória (judicial). A pessoa tem direito a ser tratada com humanidade, a informação, a acesso aos meios de comunicação, a presença médica em qualquer tempo e a não sofrer contenção sem indicação. O PS não é local de internação psiquiátrica: estabiliza, avalia e **regula para leito em hospital geral ou serviço de referência da RAPS**. Registrar em prontuário: quem solicitou, o que foi observado, por que os recursos extra-hospitalares são insuficientes, e a comunicação à família.

7. Tratamento

7.1 De-escalação verbal — os 10 domínios (Richmond/BETA 2012; ABP 2019) — primeira linha, sempre

Domínio	Como fazer
1. Respeite o espaço	Distância de 2 braços; não bloquear a saída (a dele nem a sua); não tocar sem permissão
2. Não provoque	Mãos visíveis e relaxadas, sem cruzar braços, sem olhar fixo; tom de voz baixo e lento; sem ironia, sem ordens gritadas, sem plateia
3. Estabeleça contato verbal	Um único interlocutor ; apresente-se pelo nome e função; pergunte como quer ser chamado; frases curtas
4. Seja conciso e repita	Mensagens simples; repetir com paciência (a pessoa agitada processa devagar); dar tempo para responder
5. Identifique desejos e sentimentos	"O que você precisa agora?" "Vejo que está com muita raiva/medo — me ajuda a entender o que aconteceu"
6. Escute e valide	Ouvir sem interromper; reconhecer a emoção como legítima mesmo sem concordar com o conteúdo ("faz sentido estar assustado se você sente que estão te perseguindo") — não confrontar delírio nem fingir concordar
7. Concorde ou concorde em discordar	Achar pontos de concordância ("você quer sair daqui logo, eu também quero isso"); admitir que há coisas em que não vão concordar
8. Estabeleça limites claros e não punitivos	"Aqui ninguém vai te machucar, e eu preciso que você também não machuque ninguém." Consequências reais, ditas com calma, não como ameaça
9. Ofereça escolhas e otimismo	Escolhas reais: água, comida, cobertor, ligar para alguém, sentar em outro lugar; "posso te oferecer um remédio para você se sentir mais calmo — prefere comprimido ou injeção?" ; transmitir que a crise vai passar
10. Faça o debriefing	Depois: explicar ao paciente o que aconteceu e por quê (inclusive se houve contenção), ouvir sua versão, pedir sugestões; debriefing com a equipe

Ambiente: sala silenciosa, luz moderada, sem objetos arremessáveis, sem outros pacientes, com saída visível; acompanhante presente se acalma (retirar se é gatilho). Evitar esperas longas e humilhação (alergias expostas, uniformes policiais ao lado se possível). Comunicação acessível (linguagem simples, intérprete/LIBRAS quando necessário). Registrar a tentativa de de-escalação e o motivo se falhou.

7.2 Medicação oral — preferida quando o paciente aceita (RASS +1 a +3 cooperativo) [ABP 2019; BETA]

Situação	Opções VO (adulto)	Observações
Agitação leve/moderada sem psicose (ansiedade, crise situacional, personalidade)	Diazepam 5-10 mg ou clonazepam 0,5-2 mg (SL/VO) ou lorazepam 1-2 mg	Início 30-60 min; evitar em intoxicação alcoólica/opioide, DPOC grave, idoso frágil (paradoxal/queda)
Agitação com psicose ou mania	Risperidona 2 mg ($\pm$ clonazepam 1-2 mg) ou olanzapina 10 mg (orodispersível se houver) ou haloperidol 5 mg VO (+ prometazina 25 mg)	Início 45-60 min; não associar olanzapina a BZD IM em <1 h; QTc
Delirium (idoso, orgânico)	Risperidona 0,5-1 mg ou haloperidol 0,5-1 mg VO; quetiapina 12,5-50 mg se parkinsonismo/demência por corpos de Lewy	Dose baixa; sem BZD (exceto abstinência alcoólica/BZD); tratar a causa; reorientar; família ao lado; sem contenção se possível
Intoxicação por estimulante (cocaína/crack/anfetamina)	Diazepam 10 mg VO (ou IV 5-10 mg lento), repetir a cada 15-30 min até calma	Preferir BZD; antipsicótico só se psicose persistente após BZD ($\downarrow$ limiar convulsivo, hipertermia)
Abstinência alcoólica	Diazepam 10-20 mg VO a cada 1-2 h até sedação leve (esquema por sintomas — CIWA); tiamina 300 mg IM/IV antes de glicose	Delirium tremens = UTI; sem antipsicótico isolado

7.3 Contenção química IM/IV — quando a VO é recusada ou há risco imediato [ABP 2019, Parte 2; TREC; BETA]

Esquema	Dose adulto	Idoso / debilitado	Início / repetição / máximo	Cautelas
Haloperidol + prometazina IM (padrão SUS; TREC-Rio: mais rápido que haloperidol isolado, menos distonia)	Haloperidol 5 mg + prometazina 25-50 mg IM (mesma seringa aceitável)	Haloperidol 1-2,5 mg + prometazina 12,5-25 mg	20-30 min; repetir haloperidol 5 mg a cada 30-60 min se necessário; máx. 15-20 mg/24 h ; prometazina máx. 100 mg/24 h	QTc >500 (evitar), distonia (biperideno 5 mg IM/IV), acatisia, SNM; prometazina: hipotensão, anticolinérgico — cautela em idoso/delirium
Midazolam IM (TREC: sedação mais rápida em 20 min; mais depressão respiratória)	7,5-15 mg IM (0,1-0,2 mg/kg); IV 2,5-5 mg lento	2,5-5 mg	10-20 min; repetir 5 mg após 20-30 min; máx. 30 mg/24 h no PS	Oximetria contínua e material de via aérea ; evitar em intoxicação alcoólica/opioide, DPOC grave, miastenia; antídoto flumazenil 0,2-0,5 mg IV (cautela — convulsão em usuário crônico)
Haloperidol + midazolam IM	Haloperidol 5 mg + midazolam 7,5-15 mg	2,5 mg + 2,5-5 mg	Efeito mais rápido que haloperidol isolado; mesmos máximos	Somam depressão respiratória e hipotensão; monitorar
Olanzapina IM	10 mg IM , repetir 5-10 mg em ≥2 h (máx. 30 mg/24 h)	2,5-5 mg	15-45 min	Não associar a BZD parenteral em <1 h (hipotensão/depressão respiratória); disponibilidade [VERIFICAR]
Ziprasidona IM	10-20 mg IM (máx. 40 mg/24 h)	—	15-30 min	QTc; disponibilidade [VERIFICAR]
Diazepam IV	5-10 mg IV lento (2 mg/min), repetir a cada 10-15 min	2,5-5 mg	1-5 min	Não IM (absorção errática); via aérea; abstinência alcoólica/estimulantes; flebite
Cetamina IM (delirium excitado com risco de vida, sem acesso e sem controle após BZD)	4-5 mg/kg IM (dose dissociativa)	—	3-5 min	Uso restrito, com médico ao lado, via aérea e monitor; laringoespasma, hipertensão, emergência; sem evidência ABP — opção pré-hospitalar/UTI [VERIFICAR consenso local]

Escolha por perfil (ABP 2019): psicose/mania → antipsicótico (± BZD); intoxicação por estimulante e abstinência → BZD; delirium → antipsicótico em dose baixa, sem BZD; agitação indiferenciada com violência → haloperidol + prometazina ou + midazolam; gestante → haloperidol (evitar BZD no 1º trimestre e parto); criança/adolescente → de-escalação prioritária; se necessário, prometazina 0,5-1 mg/kg IM ou haloperidol 0,025-0,075 mg/kg (máx. 5 mg) — avaliar com pediatria [dose lock]. **Após qualquer IM:** decúbito lateral, SpO₂, PA, FC a cada 15-30 min por 1-2 h; ECG assim que possível.

7.4 Contenção mecânica — último recurso, com regras [ABP 2019; NICE 2015; COFEN 427/2012; Portaria 2.048/2002]

Regra	Detalhe
Indicação	Risco iminente de dano a si ou a outros que não cedeu à de-escalação e à medicação (ou para permitir a medicação/procedimento vital); nunca por conveniência, punição, falta de pessoal ou a pedido de terceiros
Prescrição	Médica, por escrito , com motivo, horário de início, reavaliação prevista; a enfermagem pode iniciar em emergência e comunicar o médico imediatamente (COFEN 427)
Técnica	Equipe de ≥ 5 (1 líder que fala com o paciente + 1 por membro); explicar o que vai acontecer e por quê; faixas acolchoadas próprias (nunca ataduras/lençóis torcidos/algemas), 4 pontos ($\pm$ cintura), leito com grades, decúbito dorsal com cabeceira 30° (nunca ventral), sem pressão sobre tórax/pescoço; retirar objetos perigosos; permitir movimento mínimo das mãos
Vigilância	Profissional à vista contínua; checagem a cada 15 min : perfusão/pele dos membros, respiração/ SpO_2 , sinais vitais, hidratação, eliminações, conforto, sedação (RASS); alternar membros; oferecer água/alimento; reavaliação médica a cada 1 h com tentativa de retirada gradual
Duração	O menor tempo possível; retirar assim que RASS $\leq +1$ e sem violência; se $>2-4$ h, rever toda a estratégia (medicação, causa, transferência)
Registro	Formulário próprio: indicação, alternativas tentadas, horários (início, checagens, término), quem participou, intercorrências, comunicação à família; o paciente tem direito de saber o que foi registrado
Complicações a prevenir	Asfixia posicional, aspiração (vômito com sedação), rabdomiólise, TVP (profilaxia se $>12-24$ h), lesão de plexo/pele, hipertermia, trauma psíquico

7.5 Efeitos adversos e antídotos

Problema	Conduta
Distonia aguda (torcicolo, crise oculógira, trismo) por haloperidol	Biperideno 5 mg IM/IV (repetir em 30 min) ou prometazina 25–50 mg IM; manter biperideno VO 2 mg 12/12 h por 2–3 dias
Acatisia	Propranolol 10–40 mg VO; BZD; reduzir antipsicótico
Sedação excessiva / depressão respiratória por BZD	Estímulo, decúbito lateral, O_2 , via aérea; flumazenil 0,2 mg IV a cada 1 min (máx. 1 mg) só se grave e sem uso crônico de BZD/epilepsia
Hipotensão	Volume; decúbito; evitar nova dose
QTc >500 ms / arritmia	Suspender antipsicótico; K/Mg; $MgSO_4$ 2 g IV se torsades; monitor
Síndrome neuroléptica maligna (rigidez, hipertermia, disautonomia, CPK, confusão)	Suspender antipsicótico; resfriamento; volume; BZD; transferir para UTI (dantroleno/bromocriptina na referência)
Síndrome serotoninérgica	Suspender serotoninérgicos; BZD; resfriar; ciproheptadina na referência
Convulsão	Protocolo 14 (BZD; em intoxicação por estimulante evitar antipsicótico)

8. Como conduzir o caso — rede, transferência e indicadores

8.1 Articulação com a RAPS e transferência

Situação	Ação / destino
Crise psiquiátrica estabilizada, sem critério de internação	Contato telefônico com o CAPS de referência (Estiva Gerbi está vinculada ao CAPS de _____ [VERIFICAR]) no mesmo turno; acolhimento em ≤72 h; se moderado, no mesmo dia; ESF/ACS informados
Critério de internação psiquiátrica	Regulação de leito em hospital geral (enfermaria de saúde mental) ou serviço de referência da RAPS via CROSS-SP; laudo circunstanciado; consentimento (voluntária) ou pedido de terceiro + comunicação ao MP em 72 h (involuntária); transporte com acompanhante e, se necessário, SAMU (não em viatura policial como regra)
Causa orgânica/tóxica grave (delirium excitado, SNM, abstinência complicada, intoxicação grave, TCE)	Transferência clínica imediata — UTI Hospital Municipal Tabajara Ramos (rede pactuada) — Protocolos 05/13/14/23/29
Tentativa de suicídio com intoxicação	Protocolo 23; observação clínica até risco toxicológico resolvido; avaliação psiquiátrica antes da alta ; nunca alta noturna sem acompanhante
Criança/adolescente	Pediatria/CAPSij; família sempre; Conselho Tutelar se violência/negligência
Uso de álcool e drogas	CAPS AD; Consultório na Rua se houver; redução de danos; não condicionar cuidado à abstinência
Violência doméstica/sexual identificada	Notificação (SINAN), rede de proteção (CREAS, Delegacia da Mulher, Lei Maria da Penha), profilaxias se sexual — framework de documentos formais

8.2 Papel da polícia e do SAMU

- A Polícia Militar apoia a segurança quando há violência ou arma; **não realiza contenção clínica nem decide medicação**; algemas devem ser retiradas assim que a segurança permitir; o paciente é do cuidado da saúde.
- Transporte de paciente contido/sedado: SAMU com profissional de saúde, monitor e via aérea; contenção mecânica no transporte segue as mesmas regras (nunca ventral).
- Recusa de atendimento por paciente com capacidade preservada e sem risco grave é direito; com risco grave e capacidade comprometida pela crise, aplica-se a Lei 10.216 — documentar a avaliação de capacidade.

8.3 Documentação obrigatória

- Exame do estado mental estruturado (aparência, consciência, orientação, atenção, memória, pensamento — forma e conteúdo —, sensopercepção, humor/afeto, psicomotricidade, juízo crítico), hipótese sindrômica e CID-10/CIAP-2.
- Avaliação de risco (suicídio/violência) com os elementos que a fundamentam; tentativas de de-escalação e resposta; medicações (dose/via/hora) e efeitos; contenção (formulário); exames; capacidade de decisão; comunicação à família/CAPS/MP; plano de segurança entregue.
- Notificação SINAN de violência autoprovocada (imediata) e interpessoal quando aplicável.

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de agitações com glicemia, SpO ₂ e temperatura registradas em ≤10 min	≥95%
% com tentativa de de-escalação verbal documentada antes da medicação IM (exceto violência iminente)	≥90%
% com medicação VO oferecida antes da IM	≥80%
% de contenções mecânicas com prescrição escrita, checagens 15/15 min e duração registrada; duração mediana	100% / ≤2 h
Contenção em decúbito ventral, uso de ataduras/lençóis, contenção >4 h sem reavaliação (eventos sentinela)	0
% de crises com avaliação de risco de suicídio documentada (C-SSRS)	100%
% de tentativas de suicídio notificadas em 24 h e com contato ao CAPS antes da alta	100%
% de internações involuntárias com laudo e comunicação ao MP em 72 h documentada	100%
Eventos adversos: depressão respiratória, distonia, quedas, lesões em contenção, agressões à equipe	Registrar; tendência de queda

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Midazolam IM × haloperidol + prometazina	TREC-Rio: midazolam seda mais rápido (20 min) com mais depressão respiratória; haloperidol + prometazina é mais seguro e igualmente eficaz em 1 h. ABP 2019 lista ambos. Adotado: haloperidol + prometazina como padrão; midazolam quando a rapidez é essencial e há oximetria/via aérea
Dose máxima de haloperidol	ABP: até 15 mg/dia em agitação aguda; bula/prática: até 20 mg. Adotado 15–20 mg/24 h com ECG
Olanzapina/ziprasidona IM	Primeira linha em diretrizes internacionais; disponibilidade limitada no SUS [VERIFICAR]
Cetamina no delirium excitado	Evidência pré-hospitalar (EUA); ABP não recomenda; risco. Mantida apenas como opção de exceção com médico ao lado [VERIFICAR consenso da equipe]
BZD no delirium	Convergente: evitar, exceto abstinência de álcool/BZD
Contenção mecânica — tempo máximo	NICE/COFEN não fixam; ABP sugere reavaliação frequente e mínimo tempo; adotado alvo ≤2–4 h com reavaliação horária
Comunicação ao MP	Lei 10.216: dever do estabelecimento que interna, em 72 h; o PS que apenas encaminha documenta o laudo e informa — pactuar com a referência quem comunica [VERIFICAR]
CAPS de referência e leitos de saúde mental em hospital geral na região (DRS XIV)	[VERIFICAR/PACTUAR] — define o destino real dos casos
Pediatria	Doses de prometazina/haloperidol em criança sob dose lock; preferir de-escalação e pediatria/CAPSij

10. Referências

- Baldaçara L, Ismael F, Leite V, et al. Brazilian guidelines for the management of psychomotor agitation. Part 1: non-pharmacological approach. *Braz J Psychiatry* 2019;41(2):153-167. Baldaçara L, Diaz AP, Leite V, et al. Part 2: pharmacological approach. *Braz J Psychiatry* 2019;41(4):324-335.
- Richmond JS, Berlin JS, Fishkind AB, et al. Verbal de-escalation of the agitated patient: consensus statement of the American Association for Emergency Psychiatry Project BETA De-escalation Workgroup. *West J Emerg Med* 2012;13(1):17-25. Wilson MP, Pepper D, Currier GW, et al. The psychopharmacology of agitation: consensus statement of the AAEP Project BETA. *West J Emerg Med* 2012;13(1):26-34.
- Huf G, Coutinho ES, Adams CE; TREC Collaborative Group. Rapid tranquillisation in psychiatric emergency settings in Brazil: pragmatic randomised controlled trial of intramuscular haloperidol versus intramuscular haloperidol plus promethazine. *BMJ* 2007;335:869. TREC Collaborative Group. Rapid tranquillisation for agitated patients in emergency psychiatric rooms: midazolam versus haloperidol plus promethazine. *BMJ* 2003;327:708-713.
- National Institute for Health and Care Excellence. Violence and aggression: short-term management in mental health, health and community settings (NG10). London: NICE, 2015.
- Brasil. Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001. Lei nº 13.819, de 26 de abril de 2019. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.048/2002; Portaria GM/MS nº 3.088/2011 (RAPS); Guia de Vigilância em Saúde — violência interpessoal/autoprovoçada. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM nº 2.057/2013. Conselho Federal de Enfermagem. Resolução COFEN nº 427/2012.
- Posner K, Brown GK, Stanley B, et al. The Columbia-Suicide Severity Rating Scale. *Am J Psychiatry* 2011;168:1266-1277. Sessler CN, et al. The Richmond Agitation-Sedation Scale. *Am J Respir Crit Care Med* 2002;166:1338-1344.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulo de emergências psiquiátricas (página não conferida). Framework clínico institucional — módulo de saúde mental (framework_v3_mod_saude_mental).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração